جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : حسنيه عمر محمد عمر
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** دار السلام **العنوان :** -
رقم البطاقة : 25010261300907 **رقم التليفون :** 01150739457 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 26-10-1950 **المهنة :** ترزي

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج تدعيمي وتلطيفي [6579] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: حسنيه عمر محمد عمر
National ID: 25010261300907

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Supportive and palliative Treatment

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

MDT FORM 4 / 11 / 2022

G

Name	[illegible]	MRN	[illegible]
Age	71 y	ID	[illegible]
Menopausal status		Phone	01198001188
NRS SCORE	3	Marital status	[illegible]
BMI	over weight	Family history	[illegible]
CO morbidity	HTN	REASON OF MDT	

Clinical Data

BX: Lt breast IDC, grade II

ER:	PR:	HER 2:	KI67:
8/8	8/8	+ve	15%

Sonomammography:
Lt breast UOQ at 10 o'clock 2, 2.3 x 3.4 cm, Pathological Lt axillary LNs.

Mets Workup:
CT: - Isolated scattered pulm nodules in origin ? Lung

Recommendations:

R / L

cT2N1M0 IIB

for CCSM then re mdt

Lt Sm: UOQ irregular heterogeneous lesion 4.3 x 3.8 cm 2 cm fr nipple. Enhancing much. Smaller UOQ irregular mass 1.3 x 1.2 cm 1 cm fr. index mass.

MDT OUTCOME & PLAN Lt Pathological axillary. NACT hist. at core 22-12-2022

for neoadjuvant AI x 6 months then re assess. IIA / IIB

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
SIGNATURE					

CSSN F MDT 001
Version 0
Page 1
Effective Date: 1/9/2022

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Name: حسنيه عمر محمد عمر **MR. :** 2648	

Detailed Medical Report

السيد	

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من		**بشأن تقرير طبي للمريض**	
بقسم:		**رقم طبي:**	

ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :		**تاريخ وساعة الخروج :**	

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient is a 75-year-old individual with a diagnosis of left-sided breast carcinoma, clinical stage CT2N1 documented in November 2022.

Core needle biopsy demonstrated invasive ductal carcinoma, grade II. Hormone-receptor testing showed strong positivity (ER 8/8, PR 8/8), HER2 was negative (0), and the proliferation index was Ki-67 15 %. Initial sonomammography confirmed the left breast cancer, and a baseline CT of the chest, abdomen, and pelvis was reported as free of metastatic disease. Subsequent imaging identified progressive osseous involvement, including a suspicious lytic lesion of the left pubic bone in October 2024, stable lytic lesion with soft-tissue component on CT in October 2025, focal active tracer uptake at the left ischium in April 2026, and multiple sclerotic and lytic lesions of the sacrum, pubic bones, and a C4 focus on CT in August 2026, consistent with bone metastases.

The referring team recommended neoadjuvant aromatase-inhibitor therapy for six months with reassessment; the patient commenced letrozole (Femara) in December 2022. In June 2023 the MDT advised left modified radical mastectomy, which was not performed; the patient remained on letrozole despite the development of bone metastases from October 2024. Osteoporosis (DEXA T-score -3.3) was diagnosed in July 2023, prompting initiation of zoledronic acid (Zometa). Palliative radiotherapy (four fractions) to the lumbar spine and bilateral hips was delivered in August 2026 at Ahmed Maher Hospital.

تحريرا في ,

التاريخ :	23-09-2026	**الوقت :**	

الطبيب المعالج :

يعتمد ,

Patient Name	: السيدة/ حسنيه عمر محمد عمر		
Patient No.	: 2501022[illegible]900907	Request No.	: 13000235
Path No.	: 3020/22	Request Date	: 13/10/2022
Sex	: Female	Verification Date	: 05/11/2022
Age	: 71 Y	Financial Category	: اورام دار السلام - مباشره
Referreing Doc	:	Department	: Out Patient
		Registered by	: Ali mostafa

Pathology Report

CLINICAL DATA
Left breast malignant looking mass

NATURE OF SPECIMEN
Tru cut biopsy, collected at 12/10/2022 , 10:30 am

GROSS EXAMINATION
Multiple grayish white tissue cores up to 1.5 cm , totally submitted.

MICROSCOPIC EXAMINATION
- Histological type: Invasive duct carcinoma .
- Grade (differentiation +nuclear pleomorphism+mitosis): (3+2+2) Grade II
- DCIS: No
- Angioinvasion: Couldn't be detected in the received biopsy
- Perineural invasion: Positive

DIAGNOSIS
Left breast mass , Tru cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II .
For further IHC (ER,PR,HER2,Ki67)

Signature
Prof. Dr. Amal Hareedy
Dr.Heba Hassan

Verified by :
saamah sayed

Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Coraiche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt
غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: حنانية عبد محمد عبد		
Patient No.	: 250102261300907	Request No.	: 13000235
Path No.	: 3020/22	Request Date	: 13/10/2022
Sex	: Female	Verification Date	: 12/11/2022
Age	: 71 Y	Financial Category	: اورام دار السلام - مبكرة
Referreing Doc.	:	Department	: Out Patient
		IHC No.	:
		Registered by	: Ali mostafa

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT:

CLINICAL DATA : Left breast malignant looking mass
NATURE OF SPECIMEN
Tru cut biopsy, collected at 12/10/2022 , 10:30 am
GROSS EXAMINATION
Multiple grayish white tissue cores up to 1.5 cm , totally submitted.
IHC technique: Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR,HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).
MICROSCOPIC EXAMINATION
* Histological type: Invasive duct carcinoma .
* Grade (differentiation +nuclear pl[illegible]ism+mitosis): (3+2+2) Grade II
* DCIS: No
* Angioinvasion: Couldn't be detected in the received biopsy
* Perineural invasion: Positive
* IPT (Positive control showed appropriate reactivity) :
* ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (Allred score 8/8)
* PR: Strong nuclear reaction in 70% of tumor cells (Allred score 8/8)
* HER2: No membrane reaction of tumor cells (score 0)
* Ki 67: 15 % nuclear reaction of tumor cells

DIAGNOSIS
Left breast mass , Tru cut biopsy:
Invasive duct carcinoma, Grade II .
ER: Positive (score 8/8).
PR: Positive (score 8/8).
HER2: Negative (score 0).
Ki67: Positive in 15% of tumor cells

Prof. Dr. Amal Hareedy
Dr.Samah Sayed

Verified by :
saamah sayed

Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Coraiche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient Name	السيدة / حسنيه عبر محمد عبر		
Patient No.	250102261300907	Request No.	13000235
Path No.	3020/22	Request Date	13/10/2022
Sex	Female	Verification Date	12/11/2022
Age	71 Y	Financial Category	اورام دار السلام - مبكره
Referreing Doc.		Department	Out Patient
		Registered by	Ali mostafa

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Verified by :
saamah sayed

Room No. (4) - First Floor-Building No. 987- Nile Corniche - Misr El Qadema - Cairo, Egypt
غرفة رقم (4) - الدور الأول - مبنى رقم (987) - كورنيش النيل - مصر القديمة - القاهرة - مصر

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Ministry Of Health
Specialized Medical Centers
Dar El Salam Cancer Hospital
Radiology Department

وزارة الصحة والسكان
ادارة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
ادارة الاشعة

Patient Name: Hosneya Omar Mohamed Omar	Date : 16/11/2022
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 72 Year(s)
Medical ID:	

POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN & PELVIS REVEALED: -

A known case of left breast cancer

1. ***Chest:***
   - Right breast irregular speculated mass lesion measuring 1.6 x 2.9 cm.
   - Left axillary level I, II & III sub-centimetric lymph nodes are noted.
   - Bilateral scattered tiny pulmonary nodules the largest is noted at superior segment of left lower lung lobe being fissural based measuring 5 mm.
   - No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
   - No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
   - Average cardiac size. No pericardial effusion detected.
   - Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.
2. ***Abdomen and pelvis:***
   - The liver is average in size with homogenous CT texture. No definite focal lesions or contour irregularities.
   - Patent homogenously enhancing portal vein and is main branches as well as its main tributaries.
   - No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
   - Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
   - No pathological abdominal or pelvic lymph nodes.
   - Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
   - Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both supra-renals.
   - Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
   - Normal appearance of the other pelvic organs.
   - No abdominal or pelvic masses or collections.
3. ***The scanned skeleton:***

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Radiology Department

Patient Name: Hosneya Omar Mohamed Omar	Date : 16/11/2022
Exam : C.T CHEST WITH CONTRAST	Age : 72 Year(s)
Medical ID:	

- The scanned skeleton shows bilateral iliac and femoral heads tiny sclerotic lesions likely bony islands.
- Dorso-lumbar spondylosis.
- No definite worrisome lytic lesions.
- No vertebral structural collapse or extra-osseous soft tissue component.

OPINION:

- ***Bilateral scattered pulmonary nodules likely benign in nature for follow up.***
- ***No definite hepatic or osseous metastatic deposits.***

Dr. Wafaa Ali

Dr. M. Goman, M.D.

CT Scan

[[DOCTYPE:CT_SCAN]]